

PERICARDITE AIGUE

Pr RABEARIVONY Nirina
Cardiologue

PLAN

Introduction

- Signes
- Diagnostic
- Traitement

Conclusion

INTRODUCTION

Définition :

- **Péricardite** : inflammation du péricarde (infectieuse ou non infectieuse)
- **Maladies péricardiques** : péricardite (aiguë, chronique), épanchement péricardique, péricardite constrictive, tamponnade et tumeur péricardique

INTRODUCTION

Intérêts :

- **Péricardite aiguë : 27,7 cas pour 100.000 habitants par an**
- **0,1% des hospitalisations et 5% des douleurs thoraciques**
- **Mortalité hospitalière 1,1% et récurrences de 30% dans 18 mois**

SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

11. Signes cliniques

SF : Douleur thoracique (> 90%)

- Installation brutale
- majorée par la respiration et la position allongée et améliorée par la position assise penchée en avant
- Irradiation dans les muscles trapèzes
- Insensible à la TNT

SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë benigne non compliquée

11. Signes cliniques

Autres SF :

- Syndrome pseudo-grippal
- Sub fébricule
- Dyspnée

SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë benigne non compliquée

11. Signes cliniques

SP : frottement péricardique (50%)

- superficiel, aux 2 temps (mésosystolique, mésodiastolique)
- râpeux, en va-et-vient (bruit du cuir neuf)
- intensité variable, siège mésocardiaque
- durée variable (fugace: qq heures, qq jours)

SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

12. ECG : (différents stades: Holzman)

Stade I : sus décalage de ST avec T pointues (D1, D2, VL, V3 à V6)
ou sous décalage de PQ (diffus)

Stade II : retour à la normale en quelques jours

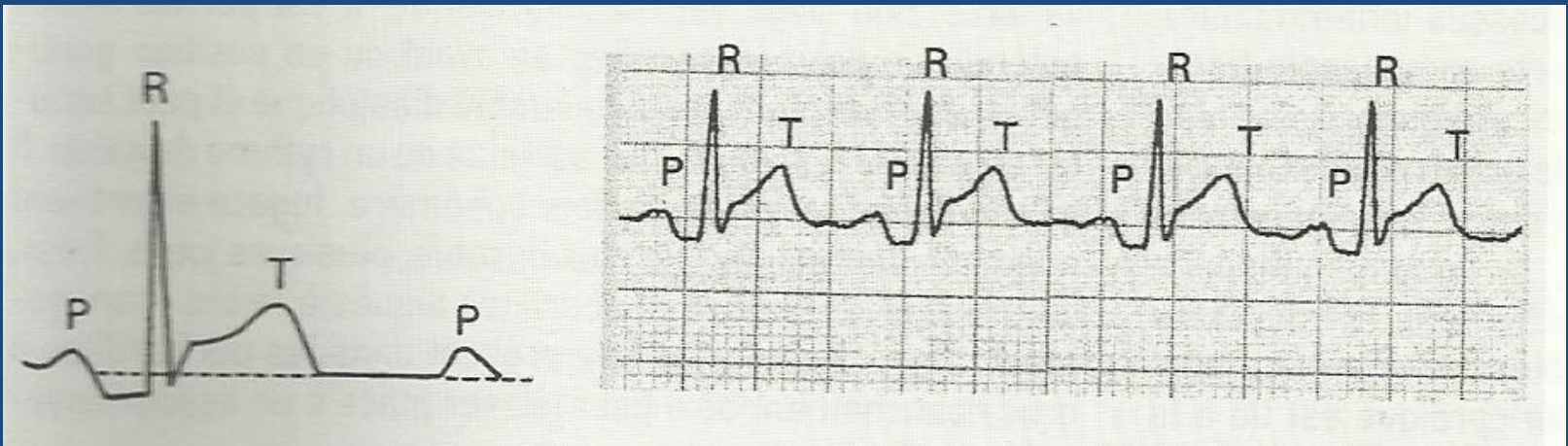
Stade III : inversion des ondes T (D1, VL, V3 à V6)

Stade IV : normalisation de l'ECG

SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

12. ECG :



SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

12. Radiographie thoracique de face :

- Cardiomégalie
(> 250 mL)
- image en « carafe »



SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

13. Echographie cardiaque transthoracique :

- Epanchement
- Vide ultrasonore



SIGNES

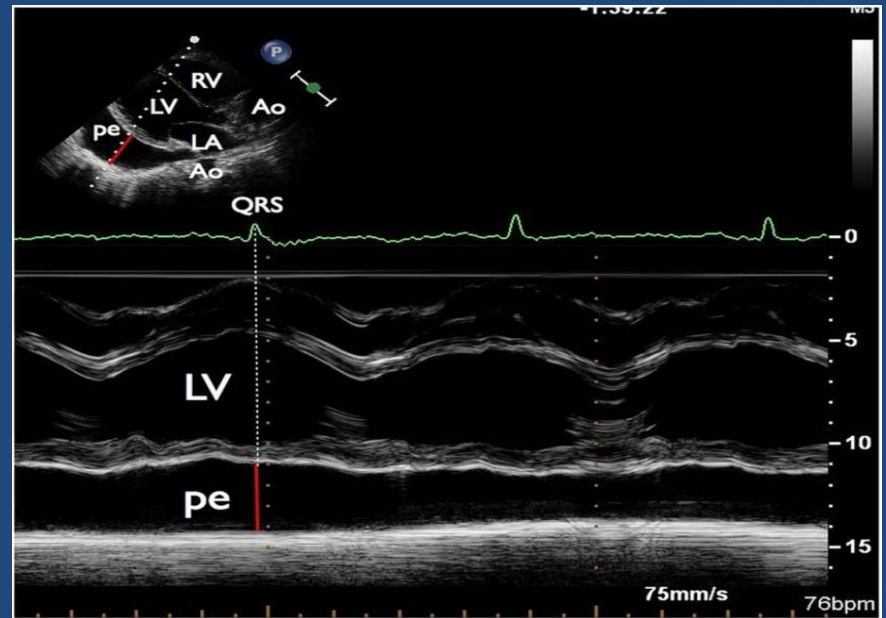
1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

13. Echographie cardiaque transthoracique:

Minime : < 10 mm

Modéré : 10 - 20 mm

Important : > 20 mm



SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë benigne non compliquée

14. TDM cardiaque avec injection :

- Epaissement non calcifié ($> 2\text{mm}$)
- Epanchement péricardique



SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

15. IRM cardiaque :

- Epaissement non calcifié (> 4 mm)
- Epanchement péricardique



SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

16. Biologie :

- Syndrome inflammatoire biologique :
NFS, VS, CRP
- Marqueurs de nécrose myocardique négatifs :
Troponine, CPK MB

SIGNES

1. TDD : Péricardite aiguë bénigne non compliquée

17. Pronostic :

- Bon à long terme
- Tamponnade rare, constriction $< 1\%$
- Récidive (incessante ou récurrente) : 15 à 30%

SIGNES

2. Formes cliniques

21. Formes évolutives

➤ *Péricardite récurrente :*

- Récidive après Intervalle sans symptôme plus de 4 à 6 semaines (< 18 à 24 mois)
- 20% d'origine virale

SIGNES

2. Formes cliniques

21. Formes évolutives

- ***Incessante*** : persistance de symptôme sans rémission claire après 4 à 6 semaines de traitement
- ***Chronique*** : persistance plus de 3 mois

SIGNES

2. Formes cliniques

22. Forme avec atteinte myocardique (myopéricardite)

- Péricardite aiguë + troponine / CPK MB positifs
- Fonction systolique du VG normale
- Origine virale , tuberculeuse (pays endémique)

SIGNES

2. Formes cliniques

23. Formes selon le terrain

➤ *Chez l'enfant :*

- Syndrome inflammatoire très marqué :
fièvre élevée et CRP plus élevé

SIGNES

2. Formes cliniques

23. Formes selon le terrain

➤ *Chez la femme enceinte :*

- Hydropéricarde bénigne du 3^e trimestre (40%)
- Péricardite aiguë : mêmes critères diagnostiques

SIGNES

2. Formes cliniques

24. Formes compliquées

➤ *Tamponnade*

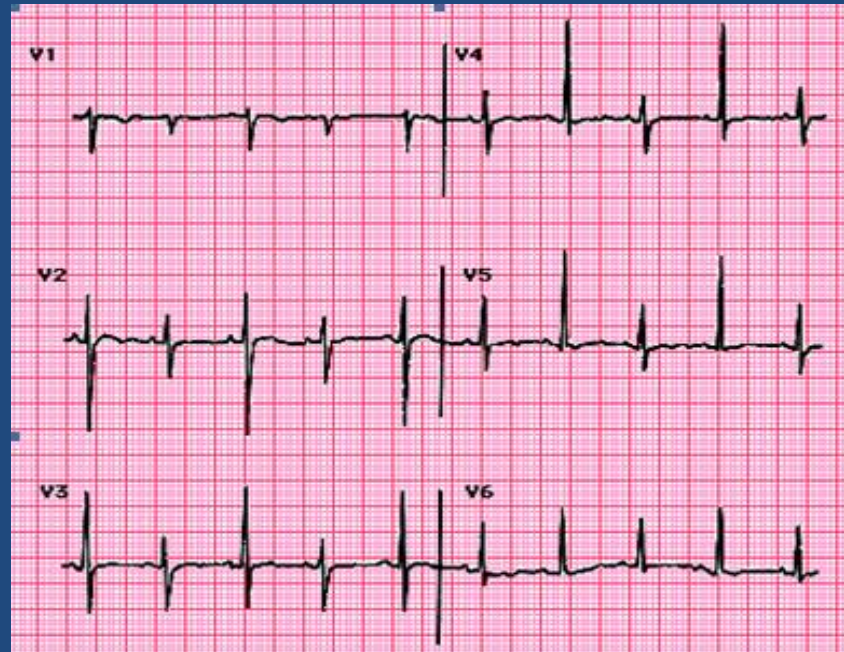
- Tachycardie, hypotension, pouls paradoxal
- ECG : alternance électrique
- Echographie transthoracique +++
- Tuberculeuse ou purulente

SIGNES

2. Formes cliniques

24. Formes compliquées

- *Tamponnade*
 - ECG : alternance électrique



SIGNES

2. Formes cliniques

25. Formes compliquées

➤ *Péricardite constrictive*

- Signes d'insuffisance cardiaque droite avec bonne fonction systolique du VG
- Radiographie thoracique (calcifications)
- Echographie transthoracique +++

DIAGNOSTIC

1. Diagnostic positif

➤ **Présence d'au moins 2 des 4 critères suivants :**

- 1- Douleur thoracique typique
- 2- Frottement péricardique
- 3- Sus décalage ST et/ou sous décalage PQ diffus
- 4- Epanchement péricardique
(nouveau ou en aggravation)

DIAGNOSTIC

2. Diagnostic différentiel

➤ Douleur thoracique aiguë

- SCA
- Embolie pulmonaire
- Dissection aortique ...

DIAGNOSTIC

2. Diagnostic différentiel

➤ Epanchement péricardique :

- Péricardite bactérienne (purulente, tuberculeuse)
- Péricardite des maladies systémiques ou auto-immune (LED, PR...)
- Péricardite urémique (insuffisance rénale)

DIAGNOSTIC

2. Diagnostic différentiel

➤ Epanchement péricardique :

- Post-cardiac injury syndromes (PCIS) :
infarctus du myocarde, chirurgie cardiaque
- Hémopéricarde (traumatique, anticoagulant ..)
- Maladie néoplasique (primitive ou métastase)

DIAGNOSTIC

3. Diagnostic étiologique

- Virale +++ : Enterovirus (Coxsackievirus, echovirus),
Herpesvirus (EBV, CMV, HHV-6),
Adenovirus et Parvovirus B19
- Idiopathique

DIAGNOSTIC

4. Diagnostic de gravité :

➤ Critères majeurs

- Fièvre $> 38^{\circ} \text{C}$
- Installation subaiguë
- Epanchement péricardique important ($> 20 \text{ mm}$)
- Tamponnade
- Absence de réponse à l'aspirine ou aux AINS après une semaine de traitement

DIAGNOSTIC

4. Diagnostic de gravité :

➤ Critères mineurs

- Myopéricardite
- Etat d'immunodépression
- Traumatisme
- Patient sous traitement anticoagulant oral

TRAITEMENT

1. Buts

- Guérir la péricardite
- Eviter les complications
- Eviter les récurrences

TRAITEMENT

2. Moyens

21. Non médicamenteux

Arrêt de l'activité sportive :

- **Non athlète : jusqu'à la normalisation de la CRP**
- **Athlète : jusqu'à la normalisation CRP, ECG, échographie, au moins 3 mois**

TRAITEMENT

2. Moyens

22. Médicamenteux

Première intention :

Drug	Usual initial dose ^a
Aspirin	500–1000 mg every 6–8 hours (range 1.5–4 g/day)
Ibuprofen	600 mg every 8 hours (range 1200–2400 mg)
Indomethacin	25–50 mg every 8 hours: start at lower end of dosing range and titrate upward to avoid headache and dizziness.
Colchicine	0.5 mg twice or 0.5 mg daily for patients <70 kg or intolerant to higher doses.

TRAITEMENT

2. Moyens

22. Médicamenteux

Deuxième intention :

- Prednisone ou équivalent
- Traitements adjuvants

TRAITEMENT

2. Moyens

22. Médicamenteux

Troisième intention :

- Azathioprine (75 - 100 mg/j)
- Immunoglobuline humaine IV (400 - 500 mg/kg/j ; 5 j)
- Anankira (inhibiteur de récepteur de l'IL-1)

TRAITEMENT

2. Moyens

23. Chirurgicaux

Péricardiocentèse :

- Guidée par l'échographie
- Drainage et biopsie péricardique
- Limites : épanchement cloisonné, postérieur, < 10 mm

TRAITEMENT

2. Moyens

23. Chirurgicaux

Fenêtre péricardique :

- Communication entre espace péricardique et cavité pleurale
- Epanchement d'étiologie maligne

TRAITEMENT

2. Moyens

23. Chirurgicaux

Péricardectomie :

- Partielle ou totale
- Traitement radical

CONCLUSION

- **Péricardite : 2 des 4 critères diagnostiques**
- **Recherche des signes de gravités nécessitant une hospitalisation**
- **Colchicine : première intention en complément du traitement conventionnel (Aspirine/AINS)**